Клинические рекомендации

Расщелина верхней губы и нёба

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**Q35** — Расщелина неба [волчья пасть] **Q36** — Расщелина губы [заячья губа] **Q37** — Расщелина неба и губы [волчья пасть с заячьей губой]
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.06.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Общероссийская общественная организация «Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1050_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определения 2

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 3

3.1 Жалобы и анамнез 3

3.2 Консультации специалистов 3

3.3 Наблюдение оториноларинголога 4

3.4 Ультразвуковой скрининг и компьютерная томография 4

4. Лечение 4

4.1 Консервативное лечение 4

4.2 Хирургическое лечение 4

4.3 Медицинская реабилитация 5

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 5

5.1 Организация медицинской помощи 5

6. Источник и актуальность 5

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 6

1. Основные положения

- Расщелина губы и (или) нёба — тяжёлый порок развития челюстно-лицевой области с нарушением непрерывности верхней губы, альвеолярного отростка и нёба и значимыми нарушениями питания, речи, слуха и носового дыхания.
- Расщепление и неправильное прикрепление нёбных мышц вызывают дисфункцию слуховой трубы: всем пациентам показано наблюдение и лечение у оториноларинголога, при необходимости тимпанотомия — для профилактики и лечения экссудативного среднего отита и сохранения слуха.
- Реабилитация длится с рождения **до 18 лет** и требует команды: челюстно-лицевой хирург, ортодонт, генетик, педиатр, оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог, логопед, психолог.
- Сроки операций: первичная хейлоринопластика — **с 3–6 месяцев** на первом году; щадящая уранопластика — **1–2 года** (при двухэтапной — мягкое нёбо в 1–2 года, твёрдое после 3–4 лет); устранение нёбно-глоточной недостаточности — **с 6 лет**; пластика альвеолярного отростка — **8–10 лет**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Расщелина верхней губы, альвеолярного отростка и нёба — врождённый порок развития с нарушением в средней зоне лица.

Составляющие порока

1. расщепление губы на два или три фрагмента;
2. деформация хрящевого отдела носа;
3. порочное прикрепление и нарушение функции пучков круговой мышцы рта;
4. дефект альвеолярного отростка верхней челюсти.

При расщелине нёба

1. сообщение полости рта с полостью носа через дефект по средней линии нёба;
2. неправильное расположение и прикрепление мышц мягкого нёба;
3. расширение среднего отдела глотки и укорочение мягкого нёба.

Уранопластика — реконструктивная операция при расщелине твёрдого нёба. Пластика мягкого нёба — при расщелине мягкого нёба. Хейлоринопластика — при расщелине верхней губы и деформации хрящевого отдела носа.

Нарушения функций

1. питание: сосание невозможно из-за сообщения полостей носа и рта, затем нарушается жевание;
2. речь: несостоятельность велофарингеального сфинктера — невнятная тихая речь с носовым оттенком, задержка речевого развития;
3. слух: расщепление и неправильное прикрепление нёбной мускулатуры вызывают дисфункцию слуховой трубы;
4. носовое дыхание: деформация концевого и костно-хрящевого отдела носа нарушает воздушный поток и способствует патологии ЛОР-органов.

2.2 Этиология и эпидемиология

Порок мультифакторный: генетическая предрасположенность или новая мутация в сочетании с неблагоприятными факторами — физическими, химическими (дефицит питания, гипо- и гипервитаминоз, тератогенные вещества и лекарства, алкоголь, наркотики), биологическими (грипп, краснуха, герпес, токсоплазмоз).

Расщелины занимают 3–5-е место среди врождённых пороков и первое (87%) среди пороков лица; частота 0,6–1,6 на 1000 новорождённых, в России около 1 на 650–700.

2.3 Классификация

1. односторонняя расщелина верхней губы: скрытая, неполная, полная;
2. двусторонняя расщелина верхней губы (симметричная, асимметричная): скрытая, неполная, полная;
3. односторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного отростка: неполная, полная;
4. двусторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного отростка: неполная, полная;
5. односторонняя полная расщелина верхней губы и нёба;
6. двусторонняя полная расщелина верхней губы и нёба;
7. расщелина нёба: субмукозная (скрытая), неполная, полная.

2.4 Клиническая картина

При полной расщелине губы всегда есть деформация кожно-хрящевого отдела носа. При односторонней — крыло носа на стороне расщелины уплощено и растянуто, кончик носа смещён в больную сторону, перегородка носа выгнута в здоровую. При двусторонней — короткая перегородка, уплощённый кончик, растянутые крылья.

Скрытая (субмукозная) расщелина нёба малозаметна: иногда вдавление слизистой оболочки между половинами мягкого нёба, несращение костных пластинок твёрдого нёба, нёбо укорочено. Характерны открытая гнусавость и нарушения артикуляции, иногда компенсаторные движения мимических мышц и крыльев носа.

При полной расщелине мягкого и твёрдого нёба видны носовые раковины, слизистая оболочка их обычно гипертрофирована; мягкое нёбо укорочено, глоточное кольцо расширено, мышцы мягкого нёба недоразвиты.

---

3. Диагностика

Диагноз клинический: визуальный осмотр, антропометрия, рентгенологические и ультразвуковые исследования. Специфической лабораторной диагностики нет — исследования по назначению генетика и предоперационный комплекс по назначению педиатра.

3.1 Жалобы и анамнез

Собирают наследственный анамнез, данные о тератогенах в I триместре и жалобы на нарушение жевания, речи, дыхания, слуха и эстетический дефект — во всех возрастных периодах.

3.2 Консультации специалистов

1. **педиатр** — общесоматический статус, сопутствующая патология перед плановой операцией
2. **челюстно-лицевой хирург** — диагноз и план лечения
3. **оториноларинголог** — состояние ЛОР-органов, профилактика осложнений
4. **ортодонт** — состояние прикуса, ортодонтическая коррекция до и после операций
5. **генетик** — генетическая патология, сопутствующие синдромы, планирование беременностей

3.3 Наблюдение оториноларинголога

Пациентам с расщелиной губы и нёба показаны наблюдение и лечение у оториноларинголога, при необходимости тимпанотомия, для профилактики и лечения экссудативного среднего отита и сохранения слуха.

Риноскопия с консультацией оториноларинголога — выявление искривления перегородки носа и сообщения полости рта с полостью носа; целесообразна детям **с 7 лет**.

Фарингоскопия (челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог) с заключением логопеда — при дизартрии, для индивидуальной программы логопедической реабилитации.

3.4 Ультразвуковой скрининг и компьютерная томография

Беременным — ультразвуковой скрининг **на 19–21-й неделе** для первичного выявления расщелин и других пороков.

КТ челюстно-лицевой области детям **6–11 лет** — оценка дефекта переднего отдела твёрдого нёба и планирование костного трансплантата; подросткам **12–18 лет** — соотношение челюстей и показания к ортогнатической операции.

---

4. Лечение

4.1 Консервативное лечение

Детям **0–3 месяцев** — ортодонтические аппараты (нёбные пластинки) для облегчения кормления, разделения полостей рта и носа и коррекции деформации челюстей до операции; далее предхирургическое ортодонтическое лечение.

Логопедическая коррекция — с дооперационного периода и после уранопластики; психологическое консультирование семьи.

4.2 Хирургическое лечение

Принципы

1. метод — по типу расщелины, степени гипоплазии и деформации окружающих структур;
2. восстановление анатомической и функциональной целостности зоны расщелины;
3. этапность с учётом соматического статуса;
4. командный подход: челюстно-лицевой хирург и ортодонт.

Первичная хейлоринопластика устраняет дефект губы и деформацию носа; рекомендуемый возраст — **старше 3–6 месяцев**, в течение первого года.

Противопоказания к ранней пластике губы: сопутствующие пороки, родовая травма, постнатальная энцефалопатия, анемия, гипотрофия — операцию откладывают до ремиссии.

Щадящая уранопластика при расщелине вторичного нёба — в **1–2 года**. При расщелине мягкого и твёрдого нёба — два этапа: пластика мягкого нёба в **1–2 года**, щадящая уранопластика **после 3–4 лет**.

Для формирования правильной речи — устранение нёбно-глоточной недостаточности после консультации логопеда и оториноларинголога; целесообразно **с 6 лет**.

Пластика альвеолярного отростка — в **8–10 лет** после ортодонтической подготовки.

Реконструктивная хейлоринопластика, хейлориносептопластика, повторная уранопластика — для устранения последствий операций. Коррекции губы возможны в любом возрасте; полная коррекция кожно-хрящевого отдела носа — **в 14–16 лет**, при деформации пирамиды носа — **до 17 лет** откладывают.

Операции после 18 лет

1. ортогнатическая операция;
2. вторичная хейлоринопластика и риносептопластика;
3. повторная уранопластика и устранение нёбно-глоточной недостаточности;
4. пластика альвеолярного отростка, дентальная имплантация.

Задачи хирургического лечения односторонней расщелины губы и нёба

Проблема	Методики
смещение основания колумеллы и перегородки носа в здоровую сторону	мобилизация и репозиция переднего края четырёхугольного хряща (методики Millard, Козина, Delaire)
деформация крыльного хряща на стороне расщелины	мобилизация крыльного хряща, поднадкостничная мобилизация мышц назолабиального комплекса
укорочение нёба, дистопия мышц нёбно-глоточного кольца	удлинение нёба, восстановление мышечной структуры: Z-пластика по Furlow, методики Фроловой, Иванова — Агеевой, Veau — Wardill — Killner, Bardach

4.3 Медицинская реабилитация

Новорождённым — специальные приспособления для кормления. Зондовое питание не рекомендуется (подавляет рефлекс глотания, усугубляет недоразвитие челюстей и мышц мягкого нёба) — только при тяжёлой соматической патологии и недоношенности; ежедневный контроль веса в первые недели.

На всех этапах — с периода новорождённости **до 18 лет** — оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог оценивают среднее ухо, рото- и носоглотку и слух; лечение симптоматическое по показаниям.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Организация медицинской помощи

Помощь — высокотехнологичная, в стационаре, плановая; госпитализации проводятся поэтапно по алгоритму лечения.

Диспансерное наблюдение — **с рождения до 18 лет** включительно.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Одно- и двусторонняя расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого нёба»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 17.06.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июня 2029 года
Код в рубрикаторе	`1050_1` · открыть текст КР ↗

Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки операций в разделе 3.2 и в приложении В («Информация для пациента») расходятся: пластика альвеолярного отростка — 8–10 лет и «начиная с 7 лет»; хейлоринопластика — «старше 3–6 мес» и «в течение первых четырех-шести месяцев»; уранопластика — 1–2 года и «от 13 месяцев».